

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	結腸直腸癌 Colorectal Cancer				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-K09	N11 莊淑娟	99 年 01 月 20 日	115 年 01 月 06 日	115 年 01 月 06 日
	護理部	核准者 吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日	
	第 3.9 版/13 頁	審查者 劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日	

一、目的

讓護理人員能瞭解結腸直腸癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

大腸是消化道的末端，約 1.5 公尺長，開始於右腸骨窩的盲腸，終於肛門處。可分為 8 部分：盲腸(cecum)、闌尾(appendix)、升結腸(ascending colon)、橫結腸(transverse colon)、降結腸(descending colon)、乙狀結腸(sigmoid colon)、直腸(rectum)及肛門(anal canal)。大腸癌發生部位以直腸最常見，約佔 50%，其次為降結腸及乙狀結腸佔 26%。此處癌症通常以腺癌的型態最常見，易經由門靜脈轉移至肝臟，目前治療方式以外科手術切除為主。

（二）症狀

1. 左側腸道癌症的臨床表現為：

- (1) 解血便或黏液便。
- (2) 排便習慣改變：腹瀉或便秘。
- (3) 糞便性狀改變：如為帶狀或細條狀。
- (4) 裡急後重。
- (5) 腸阻塞。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/13

2. 右側腸道癌症的臨床表現為：

- (1) 腹部模糊不清的不適感或痙攣痛。
- (2) 貧血。
- (3) 解血便。
- (4) 全身無力或疲倦、體重減輕、虛弱、噁心、嘔吐、厭食等。

(三) 常見檢查

1. 糞便潛血反應：為結腸癌之初步檢查方式，以檢驗大便中是否有潛血反應。
2. 肛門指診：病人不需要任何準備，由醫師戴手套以 Jelly 潤滑右手食指慢慢插入至直腸 7-8cm，直腸癌患者可能可以摸到硬塊或手套帶血（血便），是最簡單的檢查方法。
3. 肛門鏡檢(Anoscopy)：長約 8-10 公分，屬於硬的管狀器械，可以肉眼直接檢查。
4. 乙狀結腸鏡檢(Sigmoidoscopy)：此乃利用 25 公分長有照明裝置的硬管，可檢查肛管到遠端乙狀結腸，約做 60cm 的 Fiber colonoscopy。檢查時應使肌肉放鬆，採左側臥或膝胸臥式，且灌腸後即可執行；但如全大腸需做腸道準備才能做。
5. 結腸鉬劑灌腸攝影術：須事先灌腸後，經肛門灌入鉬劑，簡單省時，用空氣及鉬劑做雙重攝影，可評估整個結腸與直腸。
6. 大腸鏡檢查(Colonoscopy)：須事先灌腸，可觀察整個大腸與直腸黏膜的情形，若發現有息肉可做息肉切除，如無法切除則必須做切片檢查。
7. 組織切片檢查(Biopsy)：使用內視鏡檢查時對可疑的部分做切片，再由病理科醫師判定是否為惡性腫瘤，息肉切除後亦須送病理組織切片，確定是否有惡性變化。
8. 腫瘤胚胎抗原(Carcinoembryonic Antigen；CEA)：從大腸直腸癌細胞分離出來的蛋白，是正常細胞所沒有的，臨床上腫瘤記號蛋白用於手術後，做為追蹤大腸直腸癌有否再復發之偵測參考。
9. 腹部及骨盆腔之電腦斷層掃描(Abdominal and Pelvic CT)：藉由腹部及骨盆腔之電腦斷層掃描檢查，可以評估腫瘤侵犯深度及是否有其他組織和鄰近器官的

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/13

侵犯，及是否有淋巴或肝、肺轉移。

10. 全身正子攝影(PET-CT)：利用腫瘤組織對放射性藥物（氟化去氧葡萄糖）的吸收與代謝、轉換成體內分布影像，並結合電腦斷層，達到準確定位的功能，屬全身性的檢查。

（四）常見治療

1. 主要以外科手術切除為主，根據腫瘤的位置，常用的手術種類包括如下：

- (1) 右半結腸切除術(Right hemicolectomy, RHC)：包括切除盲腸及遠端的迴腸、升結腸，橫結腸右半部。
- (2) 左半結腸切除術(Light hemicolectomy, LHC)：包括切除橫結腸左半部、降結腸。
- (3) 次全大腸切除(Subtotal colectomy)：2／3 大腸切除。
- (4) 全大腸直腸切除(Total Radical proctectomy)：切除全部結腸，保留直腸。適用於乙狀結腸癌同時合併近端結腸癌或近端結腸破裂全大腸切除。
- (5) 高前位切除(High anterior resection)：包括降結腸、乙狀結腸切除。
- (6) 低前位切除(Low anterior resection)：適用於遠端乙狀結腸癌及中、近端直腸癌，切除範圍含下腸繫膜動脈、乙狀結腸及部分直腸。對於術前已接受放射線、化學治療或接合處在肛門上 5 公分以內之病人，可考慮是否先做暫時性人工肛門(Hartmanns)。
- (7) 前位切除術(Anterior resection)：適用於遠端乙狀結腸癌，切除範圍含下腸繫膜動脈、乙狀結腸及部分直腸。
- (8) 哈特曼術式(Hartmann's Procedure)：因為肛門仍舊保存，將來腸道可以接回復位放回腹腔。暫時性人工肛門的目的，是讓末端的腸道得以休息，避免糞便的污染以及當結腸阻塞時在病灶的近端做減壓之用。在一定的時間之後，再將人工肛門予以接合復原，放回腹腔內、恢復原來肛門的排便機能。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/13

(9)腹部會陰切除術(Abdominal perineal resection, APR):病灶在肛門邊緣 5-7cm

以內的腫瘤多施行腹部會陰手術 APR，將乙狀結腸下段、直腸、肛門切除，在腹部設置永久結腸造口，以解決排便上的問題。

(10)放射線療法：

放射線治療即是運用較高能量的放射線，約是診斷用的 X 光之能量的數百或數千倍，來破壞癌細胞，防止癌細胞的生長與分裂減輕腫瘤的大小和消除症狀，目的在減輕腫瘤的大小和消除症狀。

(11)化學療法：

化療是針對癌細胞經常在進行分裂繁殖的特性，藥物可以經由抑制癌細胞的分裂或影響其重要的生理構造運作，進而消滅癌細胞。常用的藥物有 5-FU、MTX 等。Lrinotecan(Campto)或 Oxalip 適用於治療轉移性結腸直腸癌，新藥用來作為結腸癌附屬治療藥物有 Avastin、Erbixax；其中 Avastin、Erbixax 為標靶的治療藥物，而 Sutem 為 multiple 的治療藥物。

(五) 護理問題

- 1.焦慮感受/與癌症診斷及手術施行有關。
- 2.缺乏營養/疾病及手術有關。
- 3.疼痛不適/與腫瘤壓迫腸道引起不適及術後傷口疼痛有關。
- 4.尋求(特定的)健康協助（腸道手術的注意事項）/與資料來源不足有關。
- 5.易感染/手術後傷口。
- 6.身體心像不一致/與不能接受手術後肛門造瘻口有關。

(六) 護理措施

- 1.焦慮感受/與癌症診斷及手術施行有關。
 - (1)評估病人焦慮程度及主要原因。
 - (2)請醫師解釋手術過程協助病人確認可能的壓力來源。
 - (3)向病人解釋開刀前、後的準備工作及注意事項。
 - (4)指導病人手術後咳嗽或翻身時如何固定傷口，減少疼痛。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/13

(5)讓病人瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，減少焦慮。

(6)若病人焦慮是因怕手術後的疼痛，此時醫師應給予解釋，並適時給予控制疼痛的處理。

(7)教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕焦慮。

(8)常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

(9)請家屬陪伴並給予心理支持。

(10)分散注意力，減輕恐懼，如：聽音樂、聊天。

(11)介紹病友提供經驗分享，引導個案表達自己的感覺，建立對手術的信心。

2.缺乏營養/疾病及手術有關。

(1)測量體重。

(2)依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。

(3)教導飲食進展需視腸道恢復狀況採漸進式調整。

(4)計算病人每日所需攝取熱量及實際食物的攝取量。

(5)評估有無消化不良、腹脹、腹瀉情況。

(6)避免攝取高碳水化合物和產氣性食物，以免產生腹脹情形。

(7)予衛教選擇高蛋白質、高熱量食物。

(8)依醫囑採取適當飲食。

(9)依醫囑每日供給液體輸注。

(10)依醫囑予記錄輸入、輸出量。

(11)建議少量多餐以增加進食量。

(12)鼓勵個案每天早晚至少各一次下床活動，促進腸蠕動及緩解腹脹並教導飯後 2 小時避免平躺，若必須休息，則採坐姿或側躺。

(13)採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。

(14)與營養師共同建立飲食計畫，視病人情況及需求適時修訂。

3.疼痛不適/與腫瘤壓迫腸道引起不適及術後傷口疼痛有關

(1)評估病人的疼痛程度及特徵。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/13

(2)減少或排除疼痛的因素。

(3)評估疼痛加劇的原因。

(4)利用枕頭或毛毯支持疼痛部位，教導個案及照顧者正確使用束腹帶位置並調整 2 指寬度適當鬆緊。

(5)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。

(6)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(7)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(8)與病人及家屬共同討論可控制引發疼痛的因素之方法。

(9)評估疼痛情形並主動與醫師討論，依狀況調整止痛藥劑量。

(10)評值疼痛控制技巧的效果。

(11)評估藥物的效果及副作用。

(12)鼓勵家屬多予陪伴。

(13)衛教病人咳嗽時可按壓傷口，避免牽扯疼痛。

4. 尋求(特定的)健康協助（腸造口的注意事項）/與資料來源不足有關

(1)教導觀察正常造口及周圍皮膚預防可能發生之合併症，若造口呈暗黑色表示缺血或壞死。

(2)衛教病人及家屬避免刺激性與不好消化食物，如糯米製品、肉粽、年糕、辣椒、胡椒、堅果類等。產氣食物如黃豆類、乳製品、地瓜，避免異味食物如大蒜、韭菜、洋蔥等，可以多食用茼蒿菜和香菜減少糞便氣味，並給予飲食衛教單張。

(3)協助聯繫營養師給予病人飲食衛教及出院飲食諮詢的方法。

(4)教導穿著寬鬆衣服，避免壓迫到腸造口。

(5)衛教病人仍可以維持活動如散步，但須避免劇烈運動及提重物。

(6)造口灌腸指導（如皮膚準備、人工肛門用物準備）。

(7)聯繫造口師協助每天執行造口護理，示範造口周圍皮膚清潔與便袋更換，並給予漸進式回覆示教。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/13

(8)聯繫造口師利用每次灌洗時，給予介紹各項造口物品功能與造口諮詢。

(9)衛教病人灌腸時應放鬆心情，深呼吸並做腸道按摩，以使腸道鬆弛。

(10)轉介出院準備服務小組，給予出院後定期電話訪談，與安排必要的居家照護訪視。

5. 易感染/手術後傷口

(1)監測生命徵象。

(2)監測白血球(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(3)紀錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情形。

(4)觀察傷口敷料外觀。

(5)治療前後洗手。

(6)依醫囑按時給予抗生素。

(7)依醫囑以無菌技術換藥。

(8)教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。

(9)教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。

(10)以無菌技術收集標本培養以監測感染存在。

(11)教導選擇高蛋白質飲食、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。

6. 身體心像不一致/與不能接受手術後肛門造瘻口有關

(1)以主動傾聽、開放式問題，來促進病人表達感受。

(2)以不批判態度接受病人表達自己的挫折或感受。

(3)若病人陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。

(4)給予病人足夠的時間，做開始接觸造瘻口的心理準備。

(5)以溫和漸進方式，鼓勵病人去觸摸及正視造瘻口的部位。

(6)多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，以取得病人信任。

(7)與病人討論並列出造瘻口對正常社交生活影響的範圍及因素。

(8)提供與造口有關的相關資訊，供病人參考。

(9)介紹相同的病人，彼此認識並交換意見。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/13

- (10)與病人共同計劃開始學習照護造口的日期及方式。
- (11)教導病人造瘻口護理、排泄物處理、臭味處理的方法。
- (12)當病人開始接受造瘻口，並嘗試照顧造瘻口時應給予鼓勵。
- (13)指導病人外出時先處理排泄物，並避免進食過多流質飲食。
- (14)介紹造瘻口治療師給病人認識。
- (15)出院前確認病人已接受並熟練造瘻口的護理技術。
- (16)指導病人如何調整服飾，以顯出優雅自然的外觀。
- (17)鼓勵病人參加造瘻口之友會等類似團體，取得心靈的互相支持及照護新資訊。

(七) 衛教指導

1. 增加病人對疾病的認識，並減輕其焦慮

- (1)鼓勵家屬的探訪，並安排安靜、不受干擾的環境與親友相處，教導放鬆的技巧。
- (2)安排造口師以圖片、模型、實物向病人解釋造口的部位、功能和手術後傷口的情況，及使用的物品、設備等，並鼓勵病人表達其擔心及害怕的事項。必要時，可安排成功的案例與病人會談，增加其信心。

2. 維持足夠的身體營養需要量

- (1)術前因腸道準備，被限制攝取低渣及流質飲食，營養不足處可由靜脈輸注補充。術後當蠕動恢復，依醫囑開始恢復進食，多攝取高熱量、高蛋白、高維生素、低渣的食物，但避免攝取產氣性、全奶的食物，防腹脹產生。
- (2)每天測量體重的變化，並紀錄及評估攝入和排出量。

3. 減輕手術後的傷口疼痛

- (1)避免牽扯傷口，教導咳嗽時需先按壓傷口處，以免引起疼痛。依醫囑給予止痛劑，並評估其效果。
- (2)術後鼓勵多翻身及儘早下床活動，避免久坐，減輕腹脹引起的不適。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/13

4. 認識並遵從居家照顧的注意事項

- (1)教導傷口換藥技術和評估感染徵象。
- (2)教導結腸灌洗術操作過程和注意事項。
- (3)強調避免便秘的重要性。
- (4)教導藥物服用的注意事項，如:藥名、劑量、時間、途徑、副作用等。

5. 造口日常注意事項

- (1)避免穿緊身衣物。
- (2)避免搬重物。
- (3)傷口癒合後採淋浴方式較好。
- (4)注意造口顏色及貼片剪裁需合適。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 周繡玲(2020)．消化系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（八版，425-436 頁，下冊），華杏。
- (二) 邱筱歲、吳雪紅(2019)．照護一位接受結腸直腸癌切除術後早期進食之護理經驗．源遠護理，13(2)，46-54。
- (三) 中山醫學大學附設醫院大腸直腸癌多專科團隊編修(2023)．大腸癌診療指引．中山醫學大學附設醫院。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/13

七、附件

(略)

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	11/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改結腸直腸癌定義。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	(1)醫護部改護理部。 (2)腸道手術改腸造口。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	新增參考資料。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.02.14	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過； 108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.13	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 第三項第一、三、四、五、六目內容修正。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.7	1. 第三項第五、六目護理問題及護理措施內容修正。 2. 第六項參考資料更新。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.8	第六項參考資料更新。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.9	第六項參考資料文獻更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	結腸直腸癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註